

PROY-NOM-045-SSA-2026

Prevención y Antisepsia

Criterios de bioseguridad y control de infecciones exclusivos para neonatos
y menores de 1 año

Gobierno de México • Manual de Prevención e Higiene Clínica

Estándar de Antisépticos Autorizados

Piel Intacta Neonatal

Alcohol Etílico al 70%: Único compuesto plenamente autorizado para uso rutinario en la piel íntegra de neonatos.

Balance Óptimo: Ofrece máxima potencia bactericida inmediata con baja irritación y una tasa de evaporación acelerada para proteger la dermis.

Regla de Oro: Aplicar mediante un movimiento suave, continuo y homogéneo.

Tiempo de Contacto Clínico

 **30 a 60 Segundos Completos**

Es mandatorio dejar secar el antiséptico a temperatura ambiente. No soplar, no utilizar aire forzado ni secar con gasas estériles.

Justificación: El secado forzado disminuye la eficacia bactericida del alcohol e incrementa innecesariamente la fricción cutánea.

Prohibición Absoluta de Compuestos

La inmadurez cutánea de la población neonatal contraindica el uso rutinario de los siguientes productos químicos comunes:



Yodóforos y Povidona

Riesgo Sistémico: Alta absorción transdérmica que compromete la función y el desarrollo de la glándula tiroides. Provoca manchas cutáneas profundas y de difícil remoción.



Clorhexidina Alcohólica >2%

Quemaduras Químicas: Causa desprendimiento epidérmico grave y quemaduras químicas en prematuros. No se considera estándar seguro en esta población sensible.



Fenólicos y Amonios

Toxicidad Directa: Los fenoles, sales concentradas de amonio cuaternario y lejía causan alta toxicidad cutánea y sistémica. Quedan estrictamente prohibidos en la zona de cunas.

Casos Especiales de Aplicación

Existen situaciones anatómicas y fisiológicas que requieren abordajes de antisepsia diferenciada:



Prematuros <1,000 gramos

Piel de extrema fragilidad. Se debe aplicar el alcohol etílico en capa delgada y retirar los excedentes inmediatamente, evitando la acumulación de líquido en los pliegues corporales para prevenir maceración cutánea.



Zona Umbilical

La desinfección del muñón umbilical debe realizarse exclusivamente con alcohol al 70% mediante toques suaves. Queda estrictamente prohibida la fricción intensa o el tallado brusco del tejido periumbilical.



Heridas y Mucosas

Contraindicación de Alcohol: No usar alcohol en lechos de heridas abiertas ni en mucosas. En estas zonas se debe emplear únicamente solución salina estéril isotónica o agua bidestilada estéril.

Higiene de Manos: Criterios Clínicos

Selección del Producto Adecuado

Fórmula de Elección: Soluciones alcohólicas entre **60% y 80%** con adición de emolientes para disminuir el daño dermatológico del personal.

Presentan mejor tolerancia que el lavado con agua y jabón, agilizando el flujo del turno de enfermería con idéntica tasa de desinfección bacteriana.

Exclusión de Solución Alcohólica (Uso obligatorio de Agua y Jabón):

- Manos visiblemente sucias, contaminadas con fluidos corporales o sangre.
- Atención a sospechas o brotes de *Clostridioides difficile* (esporas resistentes al alcohol).



Momentos de Higiene de Manos

La norma adopta la estrategia de los **5 Momentos de la OMS**, adicionando tres requerimientos estrictos específicos para la seguridad neonatal:

- ✓ **1. Antes de tocar al neonato:** Barrera de entrada para proteger al paciente de flora patógena externa.
- ✓ **3. Después de exposición a fluidos:** Autoprotección del personal clínico y prevención de dispersión.
- ✓ **5. Después del entorno inmediato:** Desinfección tras contacto con incubadora, cables y monitores.
- + **Adicional: Accesos vasculares:** Higiene inmediata previa a la manipulación de líneas de infusión.
- ✓ **2. Antes de un procedimiento aséptico:** Prevención en accesos vasculares, catéteres e intubación.
- ✓ **4. Después de tocar al neonato:** Remoción de patógenos adquiridos de la piel del paciente.
- + **Adicional: Manipulación umbilical:** Obligatorio antes de valorar o curar el muñón.
- + **Adicional: Retiro de guantes:** Frotar con alcohol inmediatamente después de retirar guantes estériles.

Técnica ampliada: Debe abarcar la mano completa, la muñeca y el antebrazo distal, friccionando vigorosamente durante un lapso de 20 a 30 segundos hasta el secado espontáneo.

Calidad y Control de Agua

Se establecen estándares estrictos de pureza para el agua empleada en el procesamiento de alimentos neonatales y áreas de hospitalización:

Área de Monitoreo	Cloro Residual Libre	Periodicidad de Auditoría Analítica
Lactarios y Bancos de Leche	0.2 a 0.8 ppm (Rango Estrecho)	Cada 15 días (Quincenal): Fisicoquímico y microbiológico completo.
Suministro General y Baño	0.2 a 1.5 ppm	Monitoreo sistemático de calidad de agua en red de distribución.
Cisternas y Tinacos	N/A	Cada 6 meses (Semestral): Limpieza profunda, desinfección y revisión estructural.

*Nota: Ante cualquier desviación de parámetros, se debe suspender inmediatamente el uso de la fuente, dar aviso a la UVEH e iniciar protocolos correctivos.

Monitoreo Crítico del Suministro

15
FRECUENCIA QUINCENAL
Días

Seguimiento Estricto de Redes de Agua

La norma incrementa sustancialmente la vigilancia quincenal (cada 15 días) para lactarios y bancos de leche, rompiendo el estándar de monitoreo mensual habitual de las áreas generales.

Parámetros microbiológicos: Búsqueda activa de microorganismos patógenos oportunistas, como *Pseudomonas aeruginosa*, que presentan alta letalidad en neonatología e inmunosupresión.

Ambiente Neonatal Seguro

La estabilidad microbiana del entorno directo del recién nacido depende de una infraestructura de ventilación física y superficies rigurosamente estandarizadas:

Mobiliario Clínico

Aseo Acero inoxidable, plásticos de alta densidad o vidrio. Sin grietas, porosidades ni asperezas que alberguen biopelículas bacterianas.

Renovación del

Aire Entre 6 y 12 cambios de aire por hora según el área neonatal. Mantener la temperatura constante entre 24-26 °C y humedad del 40-60%.

Saneamiento y Desinfección Terminal

Limpieza Superficial por Turno

Se debe ejecutar limpieza de superficies y barandales una vez por turno de forma rutinaria utilizando productos compatibles con el material y seguros para el contacto humano.

Desinfección Terminal: Obligatoria inmediatamente después del egreso del paciente, defunción o traslado, abarcando la cuna térmica, incubadora e instrumental adjunto.

Regla: Queda estrictamente prohibida la mezcla informal de sustancias de limpieza para evitar emanaciones tóxicas.

Gestión de Ropa y Lavandería

La ropa sucia del servicio de neonatología debe transportarse en contenedores herméticamente cerrados de forma diferenciada al resto de las áreas.

El proceso de lavado de prendas neonatales requiere temperaturas de agua controladas y desinfección final antes del planchado y empaquetado estéril.



Precauciones y Auditoría Interna

No Sobre-Desinfectar

Criterio de Preservación: El exceso de lavado o uso de desinfectantes de alta potencia sobre la piel neonatal altera de manera nociva su barrera lipídica y remueve la microbiota protectora natural.

Fijaciones Médicas: Una técnica de antisepsia dosificada previene lesiones químicas que obligan a realizar recambios tempranos de accesos vasculares y catéteres periféricos.

Auditoría y Trazabilidad

Registro de Variables: Es mandatorio asentar en bitácoras físicas o digitales:

- Concentración de cloro residual libre y pH del agua de consumo clínico.
- Tiempos de contacto de desinfectantes en cunas.
- Resultados de cultivos microbiológicos aleatorios en incubadoras.